



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TOR
PELATIHAN BUDAYA
KESELAMATAN PASIEN

RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2024

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



TOR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
“BUDAYA KESELAMATAN PASIEN”
TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

Budaya keselamatan pasien merupakan pondasi utama dalam menuju keselamatan pasien terutama di Rumah Sakit. Budaya keselamatan pasien adalah hal penting dalam kualitas layanan kesehatan, sebab menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Dalam pelaksanaannya, Direktur RS menunjukkan komitmennya tentang budaya keselamatan dan mendorong budaya keselamatan untuk seluruh staf RS. Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan seperti:

a. Perilaku yang tidak layak (*inappropriate*)

Perilaku seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama rekan kerja, misalnya mengumpat, memaki, dan menyulut emosi dengan berdebat kusir.

b. Perilaku yang mengganggu (*disruptive*)

Perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain “celetukan maut” adalah komentar sembrono didepan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain, Contohnya, mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain didepan pasien “obatnya ini salah, tamatan mana dia?”, melarang perawat untuk membuat laporan tentang kejadian yang tidak diharapkan, memarahi staf klinis lainnya didepan pasien, kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar alat bedah di kamar operasi, dan membuang rekam medis diruang rawat.

c. Perilaku yang melecehkan (*harassment*)

Perilaku ini berupa pelecehan terhadap ras, agama, suku maupun gender.

d. Pelecehan seksual (*sexual harassment*)

e. Perilaku tidak terpuji yang ditujukan untuk melecehkan lawan jenis maupun sesama jenis yang mengrah kepada tubuh, tensi seksualitas, dan orientasi seksual orang lain. Pelecehan seksual dapat berupa verbal maupun perilaku langsung kepada korban.

Komitmen organisasi menyediakan sumber daya, seperti staf, pelatihan, metode pelaporan yang aman dan sebagainya untuk menangani masalah keselamatan pasien. Masih banyak rumah sakit yang masih memiliki budaya untuk menyalahkan suatu pihak yang akhirnya merugikan kemajuan budaya keselamatan. *Just culture* adalah model terkini mengenai pembentukan suatu budaya yang terbuka, adil dan pantas, menciptakan



budaya belajar, merancang sistem-sistem yang aman serta mengelola perilaku yang terpilih (*human error, at risk behavior dan reckless behavior*). Model ini melihat peristiwa-peristiwa bukan sebagai hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi sebagai peluang-peluang untuk memperbaiki pemahaman baik terhadap risiko dari sistem maupun risiko perilaku. Budaya keselamatan mencakup mengenali dan menunjukkan masalah yang terkait dengan sistem yang mengarah pada perilaku yang tidak aman maka direktur rumah sakit perlu melakukan evaluasi rutin dengan jadwal yang tetap dengan menggunakan beberapa metode survei resmi, wawancara staf, analisis data dan diskusi kelompok.

Budaya keselamatan pasien menurut *Association Health Care and Research Quality* (AHRQ) dapat di ukur dari segi perspektif staff Rumah Sakit yang terdiri dari 10 dimensi yaitu komunikasi tentang kesalahan, keterbukaan komunikasi, serah terima dan pertukaran informasi, dukungan manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien, pembelajaran organisasi peningkatan berkelanjutan, melaporkan kejadian keselamatan pasien, respon terhadap error, kepegawaian dan kecepatan kerja, dukungan supervisor, manajer, atau pemimpin klinis untuk keselamatan pasien dan kerja sama tim. Dalam menilai budaya keselamatan pasien, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo menggunakan kuesioner Budaya Keselamatan Pasien yang di adopsi dari Kuesioner *Hospital Survey on Patient Safety Culture* dipublikasikan oleh *The Agency for Health care Research and Quality* tahun 2019. Instrumen kuesioner ini terdiri dari 38 pernyataan yang mencakup 10 dimensi budaya keselamatan pasien yang di desain untuk semua staff.

Berdasarkan hasil survey budaya keselamatan pasien pada bulan Februari 2024 dari 10 dimensi survey budaya ada 2 dimensi survey budaya yang terendah, dimensi pertama yakni pelaporan kejadian keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mencapai 55,91% dalam kategori sedang sedangkan dimensi kedua kepegawaian dan kecepatan kerja mencapai 74,91% dalam kategori sedang. Oleh sebab itu menindaklanjuti adanya budaya keselamatan pasien dalam kategori sedang, maka perlu dilakukan pelatihan budaya keselamatan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. PMK no 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKE/1128 /2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.



III. TUJUAN

1. Staf rumah sakit mengetahui bahwa kegiatan operasional rumah sakit berisiko tinggi dan bertekad untuk melaksanakan tugas dengan konsisten serta aman
2. Regulasi serta lingkungan kerja mendorong staf tidak takut mendapat hukuman bila membuat laporan tentang kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera
3. Direktur rumah sakit mendorong tim keselamatan pasien melaporkan insiden keselamatan pasien ke tingkat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Mendorong kolaborasi antar staf klinis dengan pimpinan untuk mencari penyelesaian masalah keselamatan pasien

IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini akan dilaksanakan pada:

hari / Tanggal : Selasa, 05 Maret 2024
tempat : Hall Sakura
sesi I : Jam 09.00 – 11.00 WIB
sesi II : Jam 13.00 – 15.00 WIB

V. SUSUNAN PANITIA

Ketua : Lidia Puspita Kencana, S.K.M
Sekretaris : Bening Sekar Tanjung, S.KM.
Sie Acara : Rofi'atal Manzilah, S.Psi
IT & Dokumentasi : Galih Satria Mahardika, S.Pd / Alfin Nofri Falahin, S.Kom
Nara Sumber : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.

VI. SASARAN

Sasaran pelatihan budaya keselamatan pasien adalah seluruh staf pelayanan baik staff klinis maupun non klinis di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

VII. SUSUNAN ACARA

No	Materi	Narasumber	Sesi I	Sesi II	JP
1	Registrasi Peserta	Rofi'atal Manzilah, S.Psi	09.00-09.10	13.00-13.10	-
2	Pembukaan & pre test	Lidia Puspita Kencana, S.K.M.	09.10-09.20	13.10-13.20	-



3	Budaya kerja & <i>code of conduct</i>	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.	09.20-10.05	13.20-14.05	1
4	Penyampaian materi budaya keselamatan pasien	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.	10.05-10.50	14.05-14.50	1
5	Post test	Lidia Puspita Kencana, S.K.M.	10.50-11.00	14.50-15.00	-
Total					2 JP

Ket : 1 JP (45 menit)

VIII. NARASUMBER / PEMATERI

Narasumber dalam pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien:

1. dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.. – Budaya Kerja & Keselamatan Pasien

IX. MEDIA

Media yang digunakan pada penelitian ini adalah *soundsystem, microphone*, laptop, dan LCD

X. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Demonstrasi
2. Ceramah

XI. ANGGARAN

No	Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Harga	Sumber Dana/Vendor
1	Aqua Gelas	2 dus	Rp21.000	Rp42.000	Dapur
2	Snack Pemateri (2 macam)	1 pax	Rp7.000	Rp7.000	Dapur
3	Makan Siang Pemateri	1 kotak	Rp25.000	Rp25.000	Dapur
Yang Diajukan ke PT. Disa Prima Medika				Rp0	



XII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan serta aplikasi lapangan. Pada saat perencanaan dilakukan rapat koordinasi bersama tim membahas tentang persiapan acara pelatihan kemudian dilanjutkan pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan dilakukan evaluasi berupa pre test dan post test untuk mengetahui keberhasilan dari program pelatihan melalui peningkatan nilai pemahaman dan pengetahuan dari peserta. Selanjutnya dilakukan pembuatan laporan berisi hasil dari pelatihan untuk dilaporkan ke PT Disa Prima Medika. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi pada aplikasi lapangan. Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi lapangan ini dilakukan dalam bentuk supervisi.

XIII. PENUTUP

Demikian proposal Pendidikan dan Pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempersiapkan mutu SDM yang lebih berkualitas dan professional. Untuk itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara tersebut.

Pasuruan, 22 Februari 2024

Mengetahui,
Kepala Unit SDM & Diklat
[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)
Novia Ainur Pratiwi, S.KM

Komite Mutu,
[Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini](#)
Lidia Puspita Kencana, S.K.M.

Menyetujui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.